

INFILTRACIONES GENERALIDADES

Julio Tito Camino Acha, Rubén López González, María de Mar Bances, Luis Alfredo Alonso Cuesta.

INFILTRACIÓN

Técnica o procedimiento que consiste en la inyección de fármacos en la zona anatómica (intra y/o extra articular) que producen la enfermedad, con el fin de aliviar el dolor, disminuir la inflamación y mejorar su funcionalidad. Se debe de infiltrar cuando hay un diagnóstico claro y preciso. Antes de infiltrar **siempre** informar al paciente y firmar consentimiento informado.

GENERALIDADES

- Repasar la anatomía a infiltrar.
- Asepsia y antisepsia rigurosa de la zona: Povidona yodada, alcohol 70º, etc.
- Material preparado y adecuado: guantes, gasas, campos, agujas y jeringas estériles, fármaco y anestésico.
- Evitar infiltrar en vía vascular (aspirar antes de infiltrar).
- Reposo relativo 24-48h post infiltración.
- Deporte después de más de 5 días de reposo.
- No infiltrar más de tres articulaciones en una misma sesión.
- No infiltrar una misma articulación mas de 4 veces al año.
- No infiltrar mas de 2 veces al año en la misma articulación si son ineficaces.
- Espaciar las infiltraciones entre 7 días y un mes.

INDICACIONES

- Respuesta no adecuada al tratamiento farmacológico o rehabilitador
- Mono u oligoartritis agudas o crónicas no infecciosas.
- Patología articular inflamatoria o de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES

- Reacción alérgica medicamentosa a anestésicos locales tipo amida.
- Signos de infección peri articular o articular
- Trastornos graves de la coagulación o toma de anticoagulantes
- Diagnostico no preciso
- Paciente con diabetes mal controlado
- Prótesis articular
- Desconocimiento de la técnica a usar.
- Personal médico no entrenado.

COMPLICACIONES

- Infección de la zona de infiltración, con tasa de infección: 1 /10000 infiltraciones
- Hemartros.
- Hematomas.
- Atrofia cutánea o despigmentación de la piel en la zona infiltrada.
- Lesión tendinosa
- Lesión del cartílago.

- Reacción alérgica a los fármacos usados en la infiltración.
- Aumento del dolor en la zona de la infiltración.

FÁRMACOS

Anestésicos locales

- Lidocaina 1%
- Mepivacaina HCL 1-2% sin vasoconstrictor.
- Bupivacaína B. Braun 2,5 mg/ml solución inyectable. Sin vasoconstrictor.

Corticoides

- Triamcinolonas acetato (Trigon depot®) : Ampollas de 1ml. 40 mg/ml.
- Parametasona acetato (cortidene depot®) : Ampollas de 2ml. 20 mg/ml.
- Betametasona acetato y fosfato (celestone cronodose®) : Ampollas de 2ml. 3mg acetato + 3mg fosfato/ml.

BIBLIOGRAFÍA

- http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2007/modulos/modulo1/trauma1.php : consultado:1/02/2019
- Abreu MA. Técnicas de artrocentesis. SEMFYC ediciones. Guía de Actuación en Atención Primaria: 3ª edición. Barcelona. 2006: 1742-45
- Barraquer Feu ME, Mas Garriga X. Guía de actuación en atención primaria: Infiltraciones en extremidades inferiores. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1753-6.